TEMA 4 · Gestión de servicios sanitarios y de enfermería. Prestaciones del SNS (Ley 16/2003)

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Planificación, producto sanitario y enfermero, cartera y recursos humanos · Bloque B: Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS

A1. Gestión sanitaria: tendencias actuales

- **Gestión sanitaria**: planificar, organizar, dirigir y evaluar los recursos (humanos, estructurales, tecnológicos y financieros) para atender de forma óptima y equitativa las necesidades de salud.
- Cambio de paradigma: del modelo biomédico, reactivo y hospitalocéntrico al **cuidado continuo, proactivo y comunitario** (envejecimiento, dependencia, enfermedades crónicas no transmisibles).
- **Plan de Salud de la Región de Murcia 2026-2032**: planificación continua e intersectorial con **4 áreas**: Determinantes de la salud; **Problemas de salud** (incluye salud mental temprana, Eje 2.1, y adicciones, Eje 2.2; planes de cáncer, sida, diabetes); Asistencia sanitaria (reorganización, recursos humanos, modernización del SMS); y Planificación basada en datos.

Sistema de información del SMS	Ámbito
SELENE	Atención Especializada (hospital, urgencias)
OMI-AP	Atención Primaria (centros de salud y consultorios)
GACELA	Gestión de cuidados de enfermería; mide el producto enfermero

TRAMPAS DE EXAMEN

! Salud mental y adicciones están en el **Área de Problemas de la Salud**, no en Asistencia Sanitaria.

A2. Planificación: concepto y niveles

Proceso **continuo, sistemático y formalizado** de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado desde una situación analizada. Debe ser flexible, continua y participativa.

Nivel	Plazo	Quién	Qué hace	Producto
Estratégica (normativa, macrogestión)	Largo: 4-10 años	Ministerio, Consejería, alta dirección	Misión, visión, directrices	**Plan** de Salud
Táctica (estructural, mesogestión)	Medio: 1-3 años	Direcciones de área, hospital, enfermería	**Distribuye recursos** (presupuesto, plantillas)	**Programa** de Salud
Operativa (microgestión)	Corto: ≤ 1 año	Supervisoras, coordinadores	Organiza tareas diarias	**Plan operativo**

TRAMPAS DE EXAMEN

! Asignar presupuesto, infraestructuras y plantillas = **planificación táctica**, no estratégica.

! Plan = estratégica; Programa = táctica; Plan operativo / tareas = operativa.

A3. Planificación operativa

Etapas

1. **Diagnóstico de situación** (indicadores demográficos: densidad, razón de masculinidad, envejecimiento, dependencia).
2. **Priorización** (métodos **Hanlon**, CENDES-OPS).
3. **Objetivos y metas** (población diana).
4. **Programación** de actividades, recursos y presupuesto.

5. **Indicadores de evaluación** (se diseñan **antes** de ejecutar).
6. **Ejecución**.
7. **Evaluación**.

Método de Hanlon: (A + B) × C × D

Componente	Qué mide	Puntuación
A – Magnitud	Personas afectadas (prevalencia/incidencia)	0-10
B – Severidad	Mortalidad, morbilidad, incapacidad, costes	0-10
C – Eficacia / vulnerabilidad	Capacidad de resolverlo	**0,5 a 1,5**
D – Factibilidad (PERLA)	Pertinencia, Economía, Recursos, Legalidad, Aceptabilidad	**0 o 1**

Indicadores de Donabedian

Tipo	Mide	Ejemplo
Estructura	Recursos disponibles antes de atender	Ratio enfermera/paciente, colchones antiescaras, protocolo aprobado
Proceso	Lo que se hace sobre el paciente	% de pacientes con escala de Braden al ingreso
Resultado	Efecto final en la salud	Prevalencia de UPP, bacteriemias por catéter, satisfacción

Objetivos, metas, actividades y recursos

- Objetivos **SMART** (específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporalizados).
- **Objetivo general** (propósito a largo plazo) → **objetivo específico** (hitos) → **meta** (cuantificación exacta: "95% antes del 31 de diciembre").
- Actividades: quién, qué y cuándo (**diagrama de Gantt**).
- Recursos: **humanos** (el más importante y costoso: más del 65% del presupuesto), materiales y financieros.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Si un factor PERLA vale 0, **D = 0** y la prioridad total es 0.

! Hacer la escala de Braden = **proceso**; aparición de la UPP = **resultado**.

! Los indicadores se diseñan en la **programación**, no al final.

A4. Gestión de los servicios de enfermería

- **Gestión del cuidado**: juicio profesional en la planificación, organización, motivación y control de los cuidados para lograr una atención óptima, segura y continua.
- Del modelo **funcional** burocrático (s. XX) a modelos descentralizados centrados en el paciente. Ejes: **enfermera referente** y **gestión de casos**; nuevos roles (**EPA**, indicación enfermera, RD 1302/2018); **gestión por procesos**.
- **Enfermería basada en la evidencia (EBE)**: reduce la variabilidad clínica injustificada.
- **Trayectoria o vía clínica**: plan **multidisciplinar, estandarizado y secuenciado en el tiempo** para procesos **predecibles y homogéneos** (prótesis de cadera, cataratas, parto no complicado). Detecta **desviaciones (varianzas)**. El plan de cuidados NANDA, individualizado y flexible, se reserva para pacientes complejos y poco previsibles.

A5. Producto sanitario: CMBD y GRD

- **Producto sanitario**: conjunto de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y cuidados que consume un paciente del ingreso al alta.
- **CMBD**: regulado por el **RD 69/2015** (Registro de Actividad de Atención Especializada, **RAE-CMBD**). Incluye también **CMA, hospital de día, hospitalización a domicilio** y procedimientos complejos en consultas.
  - Variables: identificación (CIP, TSI), edad, sexo, fechas, circunstancia del alta, diagnósticos y procedimientos (**CIE-10-ES**).

  - **Diagnóstico principal**: la condición que, **tras el estudio**, se establece como **causa del ingreso** (no el más grave ni el más costoso).
  - Diagnósticos secundarios: comorbilidades y complicaciones, con marcador **POA** (presente al ingreso o no).
- **GRD** (Fetter y Thompson, Universidad de **Yale**): sistema de clasificación de pacientes (*case-mix*) en unos 1.000 grupos con **coherencia clínica** e **isoconsumo** de recursos.
  - **Peso relativo**: coste esperado frente al paciente medio (1,0). **Outliers**: casos extremos de estancia o coste.
  - Limitación: se basan en el **diagnóstico médico** y no recogen la variabilidad de cuidados de enfermería.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Ingresa por apendicitis y sufre una parada en la UCI: el diagnóstico principal sigue siendo la **apendicitis**.

A6. Producto enfermero y sistemas de medición

Producto enfermero: suma de intervenciones autónomas e interdependientes, cuidados, educación y apoyo prestados para resolver diagnósticos y problemas de su competencia. Antes era invisible (un "gasto de hostelería" incluido en la estancia).

Sistema	Claves
PRN (Tilquin, Quebec)	**1 punto = 5 minutos**. Módulo I: atención directa/indirecta; II: comunicación (relevo, pase de visita, registros); III: mantenimiento de la unidad. **I + II = calidad**; **I + II + III = carga de trabajo**. 8 grupos de necesidades, 99 actividades, 249 factores; registro de 7 días
SIIPS (Francia)	Basado en las **14 necesidades de Henderson**. Cuidados básicos, técnicos y de relación/educación
SIGNO I / II (INSALUD)	Contabilidad analítica. **I**: coste **por servicio** (Grupo Funcional Homogéneo, GFH). **II**: coste **por paciente** y proceso; catálogo de productos enfermeros
NIPE (1997, Ministerio)	Integra NANDA-NOC-NIC en los **GRD** (Normas de Enfermería); no los sustituye
VASS	Clasifica el tiempo en atención **directa** (con el paciente) e **indirecta** (fuera de su presencia)

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! 12 puntos PRN = 60 min; 36 puntos = 3 horas.
>
> ! El relevo de turno y los registros están en el **Módulo II** (calidad), no en el III.

A7. Cartera de servicios

- Instrumento que hace **explícito y exigible** el conjunto de técnicas, tecnologías y prestaciones garantizadas.
- Inclusión: evaluación de seguridad, eficacia y eficiencia por la **RedETS**: valor clínico, impacto poblacional, mejora organizativa y coste-efectividad.
- **RD 1030/2006**: cartera de servicios **comunes** del SNS. Las CC. AA. pueden **añadir** (carteras complementarias con fondos propios), **nunca recortar**.
- **RDL 16/2012**: divide la cartera común en **básica** (sin copago: AP, AE, **transporte urgente**), **suplementaria** (con aportación: farmacia, ortoprótesis, productos dietéticos, **transporte no urgente**) y **accesoria**.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Ambulancia urgente = cartera **básica** (gratis). Ambulancia programada (diálisis, rehabilitación) = **suplementaria** (copago).

A8. Recursos humanos: motivación, liderazgo y comunicación

Teorías de la motivación

Teoría	Claves
Maslow	Pirámide: fisiológicas, seguridad, sociales, estima, **autorrealización**. Un nivel superior no motiva hasta cubrir los inferiores
Herzberg (bifactorial)	**Higiénicos** (salario, condiciones, política de la empresa): su falta genera insatisfacción, pero no motivan. **Motivadores** (reconocimiento, responsabilidad, autonomía, el trabajo en sí)
McClelland	Necesidades de **afiliación**, **logro** y **poder**
McGregor	**Teoría X**: el trabajador evita el esfuerzo y hay que controlarlo. **Teoría Y**: el trabajo satisface, se autodirige

Liderazgo

- **Transaccional**: intercambio, recompensas y castigos, tareas rutinarias. **Transformacional**: inspira y empodera; cambia la cultura (hospitales Magnet).
- **Kurt Lewin**: **autocrático** (útil en emergencias, frustra a largo plazo), **democrático** (más compromiso y calidad) y **laissez-faire** (desorganización; solo para equipos muy autónomos).

Hersey y Blanchard (situacional)	Estilo	Conducta del líder
M1: no sabe / no quiere o inseguro	**E1 Dirigir**	Alta tarea / **baja** relación
M2: no sabe / sí quiere	**E2 Persuadir**	Alta tarea / alta relación
M3: sí sabe / no quiere o inseguro	**E3 Participar**	Baja tarea / alta relación
M4: sí sabe / sí quiere	**E4 Delegar**	Baja tarea / **baja** relación

- **Comunicación**: asertividad y escucha activa; es una intervención de seguridad (el PRN le dedica el Módulo II).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Según Herzberg, el **salario es un factor higiénico**, nunca motivador.
! M1 y M4 (los extremos) piden **baja relación**; solo M2 y M3 piden alta relación.
! En una parada cardiorrespiratoria, el estilo adecuado es el **autocrático/directivo**.

BLOQUE B · Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS

B1. Objeto, ámbito y prestaciones

- Coordina el SNS tras completar las transferencias del INSALUD. Desarrolla los arts. **41 CE** (Seguridad Social) y **43 CE** (protección de la salud).
- **Objeto (art. 1)**: equidad, calidad y participación social; coordinación en prestaciones, farmacia, profesionales, investigación, información, calidad, planes integrales, salud pública y participación.
- **No modifica** el régimen de las mutualidades (**MUFACE, MUGEJU, ISFAS**).
- **Prestaciones**: servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción. Solo por personal habilitado y en centros propios o concertados del SNS.
- Excepción: **riesgo vital inminente** fuera del SNS; se paga solo si se justifica que **no pudieron utilizarse** los medios del SNS.
- Extranjeros en estancia temporal: para prestaciones no urgentes, informe previo favorable de los **servicios sociales** autonómicos.
- Atención especializada: incluye salud mental y paliativos; será **ambulatoria siempre que sea posible**.

Cartera común (arts. 8 a 8 quater; avalada por la STC 139/2016)

Cartera	Contenido	Financiación
Básica asistencial	AP, AE, transporte **urgente**	Pública íntegra, sin copago
Suplementaria	Farmacia con receta, ortoprótesis, productos dietéticos, transporte **no urgente**	Con aportación del usuario
Accesoria	Técnicas de apoyo no esenciales	Con aportación o reembolso

- **Enfermería en AP (RD 1030/2006, anexo II)**: EpS individual, grupal y comunitaria; vacunación; atención al crónico; atención domiciliaria a inmovilizados y cuidadores; cuidados paliativos.
- **Salud pública**: acciones **colectivas** (vigilancia epidemiológica, alertas, cribados prenatal, neonatal y oncológicos, seguridad alimentaria). **RD 568/2024**: Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública. En emergencias, las CC. AA. deben dar los datos al Ministerio.
- **Rehabilitación**: fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, solo si hay relación con un proceso tratado en el SNS.

B2. Actualización de la cartera y copago

- **Actualización (art. 21)**: por **Orden del Ministerio de Sanidad** con **acuerdo previo del CISNS**. Evaluación de tecnologías en red con las agencias autonómicas: eficacia, efectividad, seguridad, utilidad terapéutica y coste-efectividad. Las asociaciones de pacientes participan en el comité de Genética Clínica.
- Las **carteras complementarias** autonómicas se pagan **al 100% con presupuesto propio** (nunca con el Fondo de Cohesión).

Aportación farmacéutica: RDL 11/2026, de 12 de mayo (según el manual)

Colectivo	Renta	Aportación	Tope mensual
Activos	< 9.000 €	40%	8,23 €
Activos	9.000-17.999 €	40%	18,52 €
Activos	18.000-34.999 €	45%	61,75 €
Activos	35.000-59.999 €	45%	Sin tope
Activos	60.000-99.999 €	50%	Sin tope
Activos	≥ 100.000 €	60%	Sin tope
Pensionistas	< 18.000 €	10%	8,23 €
Pensionistas	18.000-59.999 €	10%	13,37 €
Pensionistas	60.000-99.999 €	10%	18,52 €
Pensionistas	≥ 100.000 €	60%	61,75 €
Mutualistas (MUFACE, ISFAS, MUGEJU)	Cualquiera	**30%**	Sin tope

- **Exentos (0%)**: IMV, rentas de integración, pensiones no contributivas, parados sin subsidio, discapacidad severa (menores con **≥ 33%**), síndrome tóxico, accidente de trabajo o enfermedad profesional.
- **Aportación reducida** (crónicos): **10% con tope de 4,98 € por envase**, sea cual sea la renta.
- **Dispensación hospitalaria**: **gratuita** para todos.

TRAMPAS DE EXAMEN

! El Ministerio **no** puede actualizar la cartera sin acuerdo del CISNS.

! Activo con 45.000 € paga 45% **sin tope**: los topes de activos solo llegan hasta 34.999 €.

! Un mutualista jubilado sigue pagando el **30%** sin tope.

B3. Garantías de las prestaciones

- **Arts. 23-29**: accesibilidad (23), **movilidad** (24: atención en cualquier CA en las mismas condiciones), **tiempo máximo** (25), información (26), seguridad y calidad (27-29).
- **RD 1039/2011**: **180 días naturales** desde la prescripción, solo para **5 cirugías**: cardiaca valvular, cardiaca coronaria, **cataratas**, prótesis de **cadera** y prótesis de **rodilla**. Excluye trasplantes y reproducción asistida. Las CC. AA. pueden fijar plazos **más cortos**, nunca más largos.
- **Murcia (Decreto 25/2006 y Ley 5/2010)**: cirugía **150 días**, primeras consultas **50 días**, pruebas **30 días**, todos **naturales**. Superado el plazo, se puede pedir la derivación a un centro concertado a cargo del SMS.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Todos los plazos de espera son en **días naturales**.
! Una hernia inguinal no está entre las 5 cirugías del RD 1039/2011.

B4. Cohesión, sistema de información y gobernanza

Fondo	Para qué
Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS)	Asistencia de **alta complejidad** a pacientes derivados entre CC. AA. (CSUR, trasplantes) y asistencia transfronteriza
Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) (RDL 16/2012)	Asistencia **ordinaria** a desplazados temporales: urgencias, AP, farmacia

- **Sistema de Información Sanitaria (SIS, arts. 53-56)**: datos de prestaciones, población protegida, recursos y financiación. El Ministerio elabora la **Encuesta Nacional de Salud**, el Barómetro Sanitario y el Índice Nacional de Defunciones. CMDIC (RD 1093/2010). Las brechas de seguridad se notifican a la **AEPD**. Conexión con el Espacio Europeo de Datos de Salud y receta electrónica europea.
- **REPS** (Registro Estatal de Profesionales Sanitarios): titulaciones, especialidades y lugar de ejercicio de **todos** los profesionales, **públicos y privados**.
- **Tarjeta Sanitaria Individual (art. 57)**: la emite la **Comunidad Autónoma**; el Ministerio fija los datos básicos y genera el **CIP-SNS**, vitalicio, en la Base de Datos de Población Protegida. Lleva Braille.
- **CISNS (arts. 69-73)**: lo preside el **Ministro/a de Sanidad**, con los **17 consejeros** autonómicos y representantes de Ceuta y Melilla. Comité Consultivo, comisiones y grupos de trabajo (solo asesoran). Aprueba la cartera común, las nuevas tecnologías y los planes integrales. Reglamento del **23 de julio de 2003**; acuerdos por consenso.
- **Alta Inspección (arts. 76-79)**: órgano estatal que supervisa a las **Administraciones autonómicas** (no sanciona a profesionales) y elabora una memoria anual.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Turista de Albacete atendido en La Manga por una gastroenteritis: lo compensa el **FOGA**, no el FCS.
! El REPS incluye también a la **sanidad privada**.
! La TSI la emite el **SMS**; el CIP-SNS lo genera el **Ministerio**.